

Manual de Voo Clínico: Anabolizantes e Gestão de Risco

Protocolos, Segurança e Redução de Danos

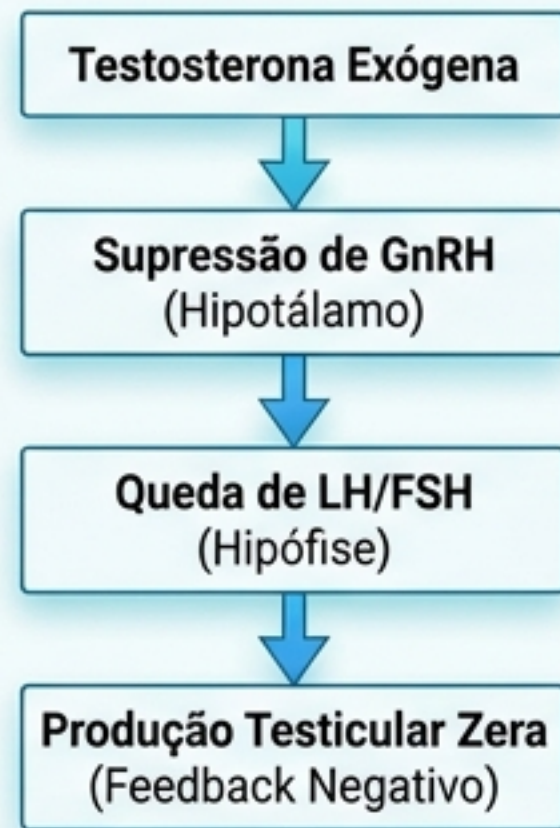
"Quanto mais deixar a mão no fogo ou quanto mais forte ele for, mais você pode se queimar"

AVISO MÉDICO E LEGAL ABSOLUTO

- * Material estritamente educacional e técnico. NÃO constitui prescrição médica.
- * NÃO incentiva, endossa ou recomenda o uso de AEAs/AAS.
- * Destinado exclusivamente a minimizar a morbidade e mortalidade endócrina, cardíaca e hepática em usuários decididos.
- * Exige profissional habilitado + monitoramento laboratorial rigoroso.

A Fundação HPT & Pilares da Prescrição

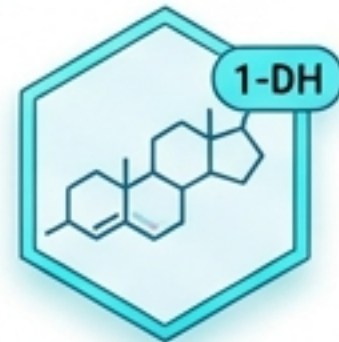
O Eixo HPT & Receptor



Insight: A regulação hormonal passa a depender do fármaco via **Ligação ao Receptor Androgênico (AR)**.

As 3 Modificações Estruturais

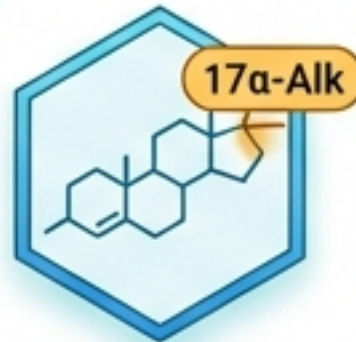
1



1-Desidrogenação

↑ Potência anabólica,
↓ Aromatização

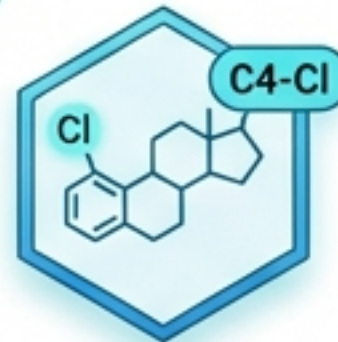
2



17α-Alquilação

Sobrevivência oral
(alto custo
hepatotóxico)

3



Mod. em C4 (Cloro)

Bloqueio **total de aromatização**

Os 3 Pilares da Prescrição



O Painel Vermelho: Alertas Clínicos Críticos

Teto de Segurança



MÁX 375 mg/sem de Testosterona. Acima disso, risco exponencial sem benefício.

Alvo E2 (Estradiol)



20-40 pg/mL. Trate sintomas, não números. Não zere o E2.

Falso-Positivo Renal



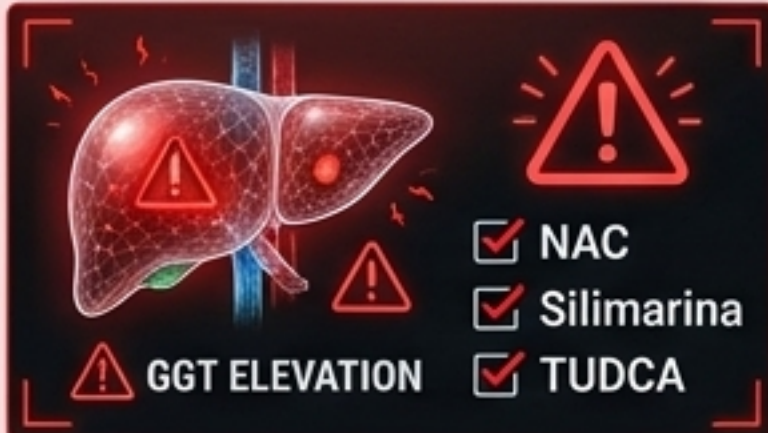
Creatinina eleva com massa muscular.
Mandatório usar Cistatina C.

Policitemia Severa



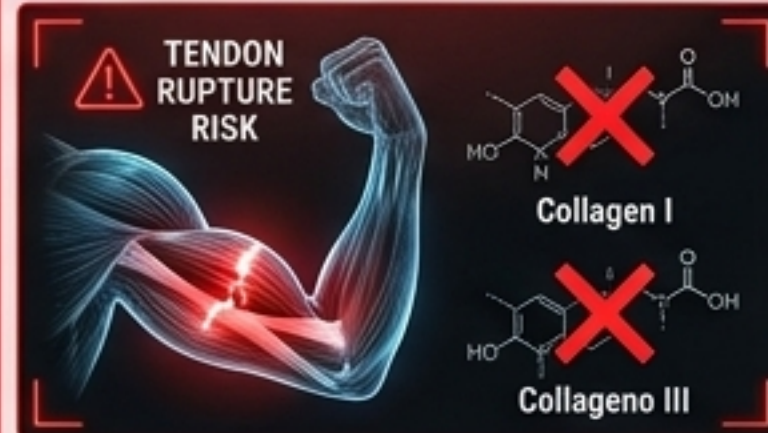
Hematócrito >52% (♂) ou >48% (♀) → Flebotomia terapêutica mandatória.

Ameaça Hepática



Colestase sem elevação TGO/TGP.
Monitore GGT. Tríade orais:
NAC + Silimarina + TUDCA.

Canhão de Vidro



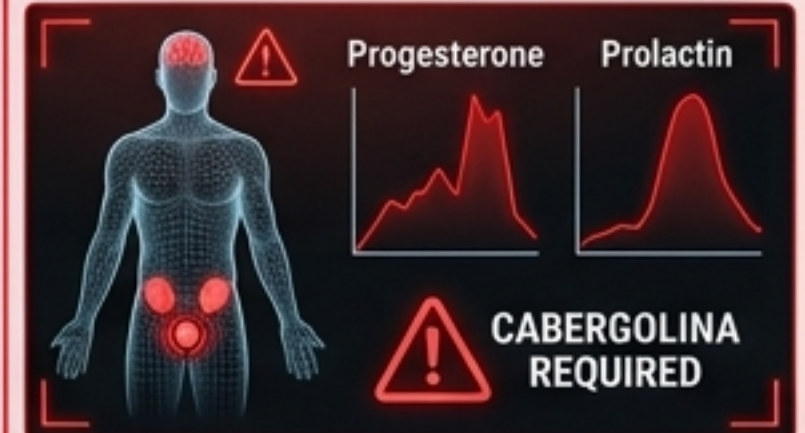
Músculo cresce, tendão não (Colágeno I → III).
Exige Vitamina C + Colágeno II.

Sinal Vermelho ♀



Virilização irreversível.
STOP imediato na disfonia (rouquidão) ou alopecia.

Deca-Dick



Disfunção com 19-Nor por saturação de progesterona/prolactina.
Uso de Cabergolina.

Framework Kaminski: As 7 Pirâmides de Risco

	Topo da Pirâmide (Risco Crítico)	Meio da Pirâmide (Atenção)	Base da Pirâmide (Mais Seguro)
Policitemia	Boldenona, Oximetolona	Testosterona	Nandrolona, Gestrinona
Lipídico/Dislipidemia	Estanozolol, Halotestin	Dianabol, Oxandrolona	Turinabol
Hepatotoxicidade	Estanozolol, Halotestin, Oximetolona	Dianabol, Oxandrolona	Turinabol, Gestrinona
Aromatização	Dianabol	Boldenona, Nandrolona	Oximetolona
Hipertensão/Rigidez	Halotestin, Dianabol	Oximetolona, Estanozolol	Trembolona
Alopecia/Acne	Estanozolol	Oxandrolona	Oximetolona
Virilização Feminina	Nandrolona, Estanozolol	Turinabol, Oximetolona	Oxandrolona, Primobolan

Família A: Ésteres de Testosterona (A Fundação)

A molécula é a mesma; o éster dita a velocidade "o risco agudo vs. cumulativo.
Dose base: 125-250mg Cruise; Teto Máx: 375mg/sem Blast.

⚠ Espectro: Impacto Imediato

Estabilidade Máxima 🛡



Suspensão
(O Sprinter)

Meia-vida: ~1h.
Freq: 1-2x/dia.
Pico imediato,
agressividade,
risco E2 agudo.



Propionato
(O Tático)

Meia-vida: 2-3 dias.
Freq: DSDN/Diária.
Controle fino,
estética seca.



Enantato/Cipionato
(O Alicerce)

Meia-vida: 5-8 dias.
Freq: 2x/sem.
Padrão-ouro
TRT e Bulking.



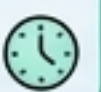
Blend / Sustanon
(A Sinfonia)

4 ésteres.
Meia-vida: 7-9 dias.
Início rápido +
sustentação.



Undecilato
(O Maratonista)

Meia-vida: 20-34 dias.
Inaplicável para
performance.
Fisiologia longa.



Família B: Arquitetura Anabólica (Orais 17 α -Alquilados & DHB)

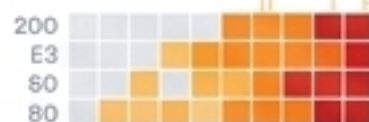
⚠ REGRA: TETO DE USO - Orais limitados a 4-6 semanas devido à hepatotoxicidade severa.

Dianabol (O Rei do Volume)

17 α + 1-desidro. Volume molhado extremo.
E2 potente (17 α -metilestradiol).



Kick-starter



Alto risco de
pressão arterial.

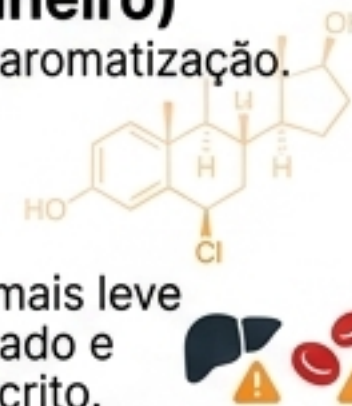


Turinabol (O Engenheiro)

Base Dbol + 4-cloro. Zero aromatização.
Ganhos secos e técnicos.



Opção mais leve
para fígado e
hematócrito.



Stat Card

Stat
Stat



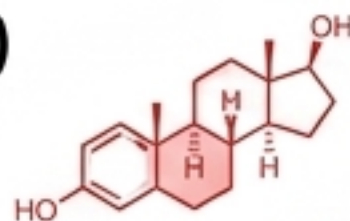
Boldenona (O Arquiteto)

Injetável (meia-vida 12-14 dias).
Aumenta apetite.



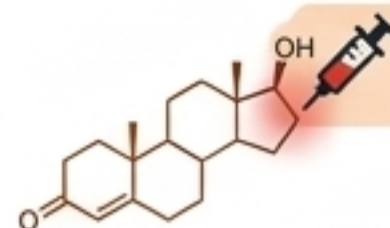
Risco Crítico:

Viscosidade sanguínea
extrema, depressão/apatia.



DHB / 1-Testo (O Predador Silencioso)

Densa e seca sem tormento psicológico.



PIP extremo (dor pós-injeção).

Destrói perfil HDL.



Metil-Testosterona

O protótipo bruto histórico.



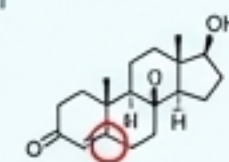
Alta hepatotoxicidade.



Largamente obsoleto.



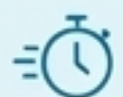
Família C: 19-Nortestosterona (A Personalidade Progestagênica)



Mecânica Central: Remoção do Carbono 19. Supressão HPT profunda. Risco de Deca-Dick (Trinômio E2+Prolactina+DHT).

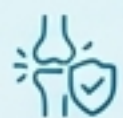
Potência Anabólica

Base Segura



NPP (Fenilpropionato):

Meia-vida 4 dias. Ação rápida, controle fácil, menos retenção. EOD.



Deca-Durabolin:

Meia-vida 8-10 dias. Offseason longo, terapêutica articular. Efeito zen.

Ancestrais/Nicho



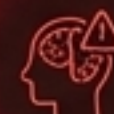
Gestrinona, Noretandrolona, Etilestrenol

Extremo Risco - O Submundo



Trembolonas (Acetato/Enantato/Hexa):

Densidade pura, zero E2.
Risco Máximo Cardiovascular (destrói HDL), Insônia, Paranoia, Roid Rage.
A ferramenta de maior custo.



MENT (Trestolona):

7-10x mais potente que testo no AR.
Aromatização violenta.



Mibolerona (Cheque Drops):

Uso em microgramas pré-luta. Constrói comportamento, não músculo.

Risco Fisiológico/SNC

Família D: Derivados do DHT (Androgênicos Estetas vs. Titãs)

Mecânica Central: Zero aromatização. Foco em dureza, redução de SHBG, definição. Alto risco genético para alopecia.

Panel 1: Os Estetas (Risco Controlado)



Primobolan (Metenolona): O mais seguro. Sem toxicidade hepática direta (único oral não-17 α). Padrão-ouro base feminina (25-50 mg/sem) e cutting.



Masteron (Drostanolona): Finalizador cristalino. Reduz SHBG, atua como antiestrogênico funcional.



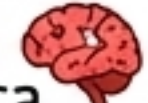
Oxandrolona: Elegância. Força sem peso. Menor toxicidade relativa. Doses ♀: 5-20mg apenas dias de treino.

Panel 2: As Marretas (Risco Extremo)



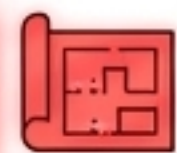
Estanozolol (A Lâmina): Força explosiva. Pior perfil lipídico e articular (seca colágeno). Topo da pirâmide de virilização ♀. 



Halotestin (A Marreta): Picos de força absoluta. Destruição hepática e psicológica. 

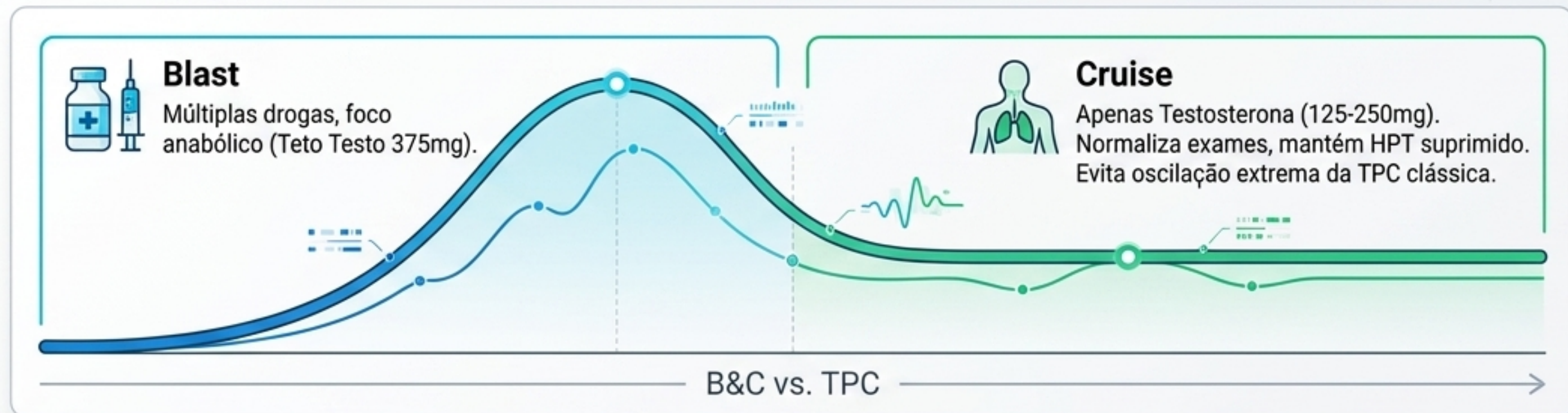


Hemogenin / Superdrol: Volume extremo, hepatotoxicidade severa. 



Moduladores: Proviron (arquiteto via ↓SHBG), DHT Injetável. 

Arquitetura de Aplicação: Blast & Cruise e Sinergias



Sinergias Inteligentes

O Motor: Testosterona

Sempre a base biológica.



O Corretor: DHT Injetável + 19-Nor

DHT corrige a libido derrubada pela supressão típica da trembolona/deca.

O Refinador: Masteron + Testo

Masteron reduz SHBG, atua como antiestrogênio funcional, poupando IAs e protegendo artérias.